



République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique
Université Constantine 3
Faculté De Médecine
Département De Médecine



Cours de sémiologie :

La sémiologie vasculaire pathologique

Dr ZINEB BOUACHIBA
Maitre-assistant en Médecine Interne- EHDM

Enseignement de 3ème année médecine.
Année universitaire 2024-2025.

I. Définition de la séméiologie vasculaire :

Ensemble de signes cliniques en rapport avec une maladie acquise ou congénitale artérielle et/ou veineuse ou lymphatique

II. Interrogatoire du patient vasculaire :

- L'interrogatoire est **une étape essentielle** de l'examen clinique, particulièrement chez le patient vasculaire. Il permet de recueillir des informations précises et exhaustives grâce à une communication adaptée au niveau socioculturel du patient.
 - Le médecin doit faire preuve d'écoute, d'empathie et d'esprit critique pour instaurer une relation de confiance.
 - L'interrogatoire doit être structuré, avec des questions **neutres et ouvertes**, afin d'orienter le discours vers les éléments pertinents pour le diagnostic.
- Il couvre :
- le motif de consultation ou d'hospitalisation
 - L'historique médical : L'analyse chronologique
 - Les antécédents, Le mode de vie, facteurs de risque
 - Les symptômes,
 - les traitements en cours.

1. Motif de consultation ou d'hospitalisation :

L'interrogatoire médical suit un déroulement souple et non linéaire, avec des ajustements pour clarifier les informations.

Il débute généralement par la définition du problème du patient et de ses attentes (soulagement, diagnostic, pronostic, avis thérapeutique, etc.).

Cette approche permet de centrer l'entretien sur ses préoccupations, d'y répondre efficacement et de renforcer la confiance, favorisant ainsi un recueil d'informations de meilleure qualité

2. Histoire de la maladie :

- L'historique des troubles fournit des informations essentielles pour le diagnostic et le pronostic.
- Il repose sur une analyse chronologique du problème perçu par le patient ou de la maladie déjà connue.
- Cette démarche inclut la description détaillée des antécédents, ainsi que les résultats d'exams, interventions et hospitalisations. Chaque symptôme est ensuite analysé chronologiquement, et une synthèse finale est réalisée dans les cas complexes.

3. Les antécédents , Le mode de vie ,Les facteurs de risque :

Le recueil des antécédents familiaux et personnels est essentiel chez le patient vasculaire, car de nombreuses maladies vasculaires sont chroniques et présentent un risque héréditaire, comme les varices primitives, le phénomène de Raynaud ou la maladie thromboembolique. Il est important de préciser le type d'accident vasculaire, les circonstances de survenue et le lien familial, notamment dans les pathologies génétiques comme les thrombophilies.

Le mode de vie influence aussi ces maladies, tant pour l'identification des facteurs de risque que pour adapter la prise en charge. Certains métiers et habitudes, comme la station debout prolongée, les longs trajets ou l'utilisation d'outils vibrants, peuvent être des causes directes de pathologies vasculaires. De même, des sports pratiqués intensivement peuvent entraîner des troubles similaires.

Enfin, la majorité des maladies vasculaires étant multifactorielle, il est crucial d'évaluer les facteurs de risque constitutionnels (âge, sexe, hérédité) et acquis (tabagisme, alimentation, troubles métaboliques, traitements hormonaux, sédentarité). Cette analyse permet une meilleure prévention et une prise en charge adaptée des pathologies comme l'athérosclérose, l'insuffisance veineuse chronique et la maladie thromboembolique.

4. symptômes vasculaires (analyse) :

La description des symptômes vasculaires doit être précise, en détaillant leur type, localisation, intensité, évolution, signes associés et circonstances d'apparition. Dans les pathologies vasculaires, ces circonstances sont souvent plus informatives que la nature même de la douleur, comme pour la claudication intermittente ou l'insuffisance veineuse. Les douleurs peuvent résulter d'une souffrance tissulaire en aval (artériopathies) ou en amont (maladies veineuses), mais aussi d'inflammations, thromboses ou dissections vasculaires.

Les sensations de froid ou de chaleur aux extrémités doivent être objectivement évaluées par thermométrie ou palpation avant d'être attribuées à un trouble vasculaire. De même, des modifications de couleur (acrosyndromes) ou des dysfonctionnements d'organes (dyspnée, fatigue, troubles érectiles) peuvent révéler une atteinte vasculaire sous-jacente.

5. Traitement en cours :

Le recueil détaillé des traitements en cours est essentiel pour orienter les décisions médicales, identifier d'éventuels facteurs iatrogènes et détecter des antécédents pathologiques que le patient aurait omis de signaler.

6. Examen clinique complet :

Rechercher des symptômes révélateurs de dysfonction des différents systèmes : cœur, systèmes respiratoire, neurologique, digestif, urinaire et génital.

NB : L'interrogatoire permet le plus souvent d'évoquer le diagnostic, qui sera confirmé par les données de l'examen clinique parfois parachevé par des examens complémentaires.

III. EXAMEN PHYSIQUE DU PATIENT VASCULAIRE :

L'examen physique vasculaire, guidé par l'interrogatoire, aide à orienter le diagnostic, évaluer son impact et dépister d'éventuelles affections asymptomatiques influençant la prise en charge. Sa réalisation peut nécessiter divers outils comme un tensiomètre, un stéthoscope, un Doppler de poche, un mètre ruban, un garrot, un marteau réflexe et un monofilament.

A- Sémiologie artérielle :

1- Inspection :

-L'inspection commence avec le patient debout pour évaluer : sa morphologie, sa posture et sa démarche, puis se poursuit en position allongée sur le divan d'examen.

L'examen physique débute par la collecte de **données morphométriques** (taille, poids, IMC, tour de taille) et l'observation de **l'attitude du patient**, notamment en cas de **position antalgique**.

- L'inspection évalue aussi la voûte plantaire, les membres pour détecter des asymétries,

- apprécier **la couleur** de la peau (pâleur, cyanose, érythrose).

Rechercher **Les troubles des phanères et trophiques** (peau sèche, ulcères) indiquent des problèmes vasculaires graves.

-L'examen **des trajets artériels et veineux** permet d'identifier des anomalies comme des anévrysmes ou une mauvaise visibilité du réseau veineux ou la présence de varices

- À l'état pathologique :

Elles deviennent visibles dans :

- L'athérosclérose : **le signe de la sonnette** qui réalise un mouvement de reptation de l'artère humérale ; sinueuse et très battante ; à chaque systole.
- L'insuffisance aortique : **le signe de Musset** ce sont des secousses rythmiques de la tête lorsque celle-ci est légèrement fléchie.
-

2- La palpation :

2.1. PALPATION DES TÉGUMENTS :

L'examen cherche d'abord :

- **une chaleur accrue** peut indiquer une infection, une inflammation ou une thrombose,

-**température réduite ou froideur** suggère une ischémie sévère.

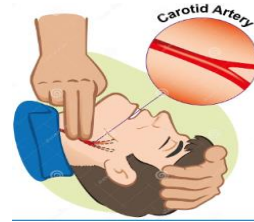
-**L'œdème** est quantifié en mesurant les circonférences à différents niveaux du membre, en notant sa localisation et son caractère (uni ou bilatéral, dépressible ou non). On recherche également des signes comme l'épaississement du pli cutané ou l'impossibilité de pincer la peau (signe de Stemmer).

-**La mobilité articulaire** est évaluée pour comprendre ses impacts sur la déambulation et la circulation veineuse.

-**la palpation des masses musculaires** permet de noter toute douleur associée.

2.2. PALPATION DES TRAJETS ARTÉRIELS :

- **L'examen des pouls périphériques** : est essentiel en clinique. Il se fait en décubitus dorsal en palpant les trajets artériels des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que d'autres artères comme la carotide et la



temporale. Toute asymétrie ou absence de pouls peut révéler une pathologie artérielle. La présence d'une masse pulsatile expansive évoque un anévrisme, tandis qu'un thrill signale des turbulences dues à une sténose ou une fistule artérioveineuse

- Elle doit être systématique et symétrique.
- Pulpe des 2ème, 3ème et 4ème doigts,
- Elle doit être douce.

- **Cou :**

Les artères carotides : le pouls carotidien palpé au mieux chez un sujet assis, tête légèrement fléchie de côté à examiner en avant de MSC au-dessous de l'angle mandibulaire.

On commence par un côté puis l'autre, pas les deux à la fois.



- **Membre supérieur :**

- L'artère humérale : **Le pouls huméral** se cherche en dedans de chef de biceps au niveau de la gouttière brachiale juste au-dessus de pli de coude



-L'artère radiale : **Le pouls radial** se palpe au niveau de la gouttière radiale de côté de pouce .

- **Au membre inférieur :**

- L'artère fémorale : **le pouls fémoral** palpable au niveau de triangle de Scarpa (ou trigone fémoral).



- L'artère poplitée : **Le pouls poplité** mieux palpé dans la région externe de creux poplité ; la jambe légèrement fléchis en empoignant le genou, les doigts en crochet.



- L'artère tibiale postérieure : **le pouls tibial** se palpe à environ 1 cm en arrière de la malléole interne.



-**Le pouls pédieux** : sur le dos du pied entre le premier et le deuxième rayon, néanmoins non palpables de manière physiologique chez 10% de la population.



➤ Au niveau de tronc :
L'aorte abdominale : quand on sent les pulsations de l'aorte, on essaye de l'entourer de ses doigts



À l'état normal :

- Les artères sont souples et dépressibles.
- Tous les pouls périphériques doivent être normalement retrouvés à l'exception parfois des pouls pédieux.
- 2 artères symétriques ont des battements égaux et synchrones.
- Le pouls carotidien est synchrone du B1.
- Le pouls radial et le pouls fémoral sont synchrones.
- Le pouls est régulier, sa fréquence est la même que la fréquence cardiaque.

Les anomalies du pouls artériel :

- Les troubles du rythme cardiaque.
- Les modifications de l'amplitude des battements artériels.
- La perception de frémissement ou thrill.

a- Les troubles du rythme cardiaque : il s'agit soit de

- Irrégularité -arythmie
- Bradycardie
- Tachycardie

b- Les modifications de l'amplitude des battements artériels :

- L'affaiblissement général des pouls :
- Microsphygmie (diminution du débit cardiaque)

- Rétrécissement aortique (RA)
- Insuffisance cardiaque gauche (ICG)
 - L'affaiblissement ou disparition élective d'un pouls artériel :
- Artérite (inflammation d'une artère)
- Thrombose ou embolie
 - L'affaiblissement ou abolition des pouls fémoraux :
- Coarctation de l'aorte
- thrombose de la partie terminale de l'aorte
- Thrombose des deux artères iliaques.
 - L'augmentation généralisée d'amplitude des pouls artériels :
- Éréthisme cardiaque
- Hyperthyroïdie
- Insuffisance aortique (IA) : pouls de Corrigan
 - L'amplitude du pouls peut varier avec les mouvements respiratoires : Pouls paradoxal de Kussmaul
- Épanchement péricardique de grande abondance.
- La péricardite constrictive.

c- La perception de frémissement ou thrill :

- Systolique : les anévrismes artériels
- Systolo-diastolique : fistule artério-veineuse



d- La perception des masses pulsatiles :

- Une masse battante et expansive : **un anévrisme**,
- une masse avasculaire peut battre sans expansion.
- Une expansion globale de l'artère : **une méga-artère**



3- L'auscultation :

À l'état normal :

Les artères sont silencieuses à condition de ne pas les comprimer.

À l'état pathologique :

L'apparition d'un souffle systolique, souffle systolo-diastolique ou un souffle continu est pathologique.

- **Aux artères carotides :**
 - Thrombose ou sténose de la carotide
 - RA (irradiation du souffle de RA aux carotides)
- **Gros troncs artériels :** la sous-clavière dans le creux sus-claviculaire, l'axillaire en sous-claviculaire :
 - Rétrécissement artériel athéromateux : Souffle Systolique
 - Anévrisme artériel : Souffle Systolique

- Anévrysme artério-veineux : Souffle continu

- **Artère rénale :**

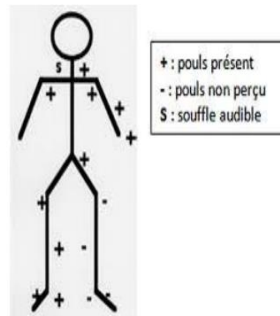
-Sténose rénale : Souffle Systolique unilatéral, latéro-ombilical ou sus ombilical. Au niveau des flancs et en lombaire

- **Artère fémorale :**

-Insuffisance aortique (IA) : double souffle crural de Duroziez (S systolique et S diastolique).

-sténose fémorale.

Au terme de l'examen vasculaire, on put consigner nos données sur un schéma daté



4. Mesure de la pression artérielle :

4.1. Définition : la pression artérielle est la pression sous laquelle le sang circule à l'intérieur des vaisseaux, mesurée au niveau de l'artère humérale, exprimée en : cm d'eau ou en mm Hg.

- Une valeur maximale ou systolique : synchrone de l'arrivée de l'onde systolique, et

- Une valeur minimale ou diastolique synchrone du relâchement musculaire ventriculaire (diastole).

La pression différentielle ou appelée encore couramment différentielle est définie comme l'écart entre la pression maximale et la pression minimale.

4.2. Technique de mesure :

-Sphygmomanomètre = appelé couramment tensiomètre

- Le malade : position couchée ou assise

- Brassard : 1/3 inférieur de bras

- Effectuée aux deux bras

- Après 15 min de repos

- Elle peut se faire en position debout : la recherche d'hypotension orthostatique

- Profil tensionnel : **la règle des 3.**

3 mesures consécutives (à 1-2 minutes d'intervalle), **le matin** : avant le petit déjeuner (avant de prendre ses médicaments).

3 mesures consécutives (à 1-2 minutes d'intervalle), **le soir** : avant le coucher.

3 jours de suite au minimum, et si possible pendant 5 à 7 jours.

4.2.1. La méthode auscultatoire : C'est la méthode de référence et la plus ancienne. En pratique, le brassard est gonflé jusqu'à un niveau de pression supérieur à la pression systolique (jusqu'à 250 mm Hg), ce qu'on



vérifié par la disparition du pouls radial, puis il est lentement dégonflé.

Le stéthoscope est placé immédiatement en aval du brassard, au niveau de l'artère humérale.

-La pression artérielle systolique (PAS) correspond à l'apparition des bruits.

-La disparition des bruits correspond à la pression artérielle diastolique (PAD).

4.2.1. La méthode palpatoire :

Palpation du pouls lors du dégonflage d'un brassard placé en amont n'est qu'une méthode approximative qui, en outre, ne fournit que la pression artérielle systolique (apparition du pouls).



4.2.3. Autres méthodes :

- Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) :

Elle évalue par des mesures répétées sur 24 heures le niveau et la variabilité tensionnels.

- L'automesure :

Permet de disposer d'un nombre éventuellement important de mesures sur une période suffisamment prolongée. Elle évite en particulier le surcroît de pression lié à la réaction d'alarme au cabinet médical (effet « blouse blanche »).

Résultats :

Normal : PAS $\leq$ 140 mm Hg

PAD $\leq$ 90 mm Hg

-Varie en fonction de l'âge.

- Différence de pression acceptable $\leq$ 20 mm Hg (pour la PAS)

Les anomalies de la pression artérielle :

- L'hypertension artérielle
- L'hypotension artérielle
- Les anomalies de la différentielle

a) L'hypertension artérielle :

PAS $>$ 140 mm Hg et, ou

PAD $>$ 90 mm Hg

b) L'hypotension artérielle :

- Collapsus cardiovasculaire
- insuffisance surrénale lente
- Hypotension des sujets jeunes et/ou sportifs

c) Les anomalies de la différentielle :

-Elargissement : IAO ex : 150/30 mm Hg (insuffisance aortique)

- Pincement :

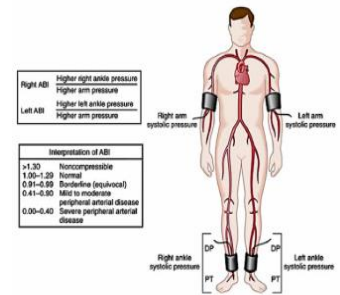
IC ex : 90/70 mm Hg (insuffisance cardiaque)

5. Index de Pression Systolique :(IPS) l'intérêt dans la recherche d'une artériopathie des membres inférieurs.

- Un brassard pneumatique placé à la cheville est dégonflé, tandis que la pression systolique est mesurée avec une sonde Doppler au niveau de l'artère pédieuse ou tibiale postérieure.



- Cette pression systolique à la cheville est rapportée à la pression systolique humérale, pour obtenir l'index de pression systolique (IPS) que l'on considère anormal s'il est inférieur 0,9.



$$\text{IPS} = \text{PAS cheville} / \text{PAS bras} = 0,9 \text{ à } 1,3$$

6. Les syndromes d'ischémies des membres

6.1 L'ischémie aiguë:

- une occlusion artérielle brutale par un embole sanguin venant du cœur gauche, il s'agit d'une **urgence** diagnostic et thérapeutique qui sera reconnue par les signes suivant :

- une **douleur violente** au niveau du membre ischémié.
- une **impotence fonctionnelle** totale avec troubles neurologique
- une **pâleur extrême** de marbre blanc associée à un **refroidissement** du membre perçu par le malade et palpe par le médecin
- une **abolition des pouls** en aval de l'oblitération
- en absence de traitement l'évolution se fait inévitablement vers la gangrène.



6.2. Ischémie chronique

- une oblitération partielle et progressive d'une artère,
 - artérite oblitérante des membres inférieurs
 - elle évolue en 04 stades :

- **Stade I** : absence de signes fonctionnelle, mais diminution ou abolition d'un ou plusieurs pouls
- **Stade II** ou stade d'ischémie d'effort : caractériser par la claudication intermittente : il s'agit d'une douleur a type de crampe sans contracture musculaire qui apparait à l'effort lors de la marche, surtout si elle est accélérée, qui disparaît lors du repos, et qui réapparaît pour le même effort. Cette douleur siège soit à la fesse, soit à la cuisse, soit au mollet, Elle s'aggrave dans le temps, apparaissant pour une distance de plus en plus faible : la diminution du **périmètre de marche**.
- **Stade III** ou stade d'ischémie de repos : caractérise par une douleur permanente existant même au repos, exagérée par le décubitus accompagne de trouble vasomoteur a type d'érythrocyanose
- **Stade IV** : c'est le stade de la gangrène qui est la nécrose du segment d membres ischemie, elle évolue en 02 phases :
 - phase sèche aseptique : peu douloureuse
 - phase humide : elle s'accompagne d'une infection et les douleurs deviennent plus intenses



A ce stade l'amputation du segment gangrené est indispensable d'où l'importance du diagnostic précoce d'une artérite avant l'apparition de la gangrène

B- Sémiologie veineuse :

L'examen de système veineux comprend : L'examen des veines jugulaires e L'examen des veines des membres inférieurs

1. L'examen des veines jugulaires :

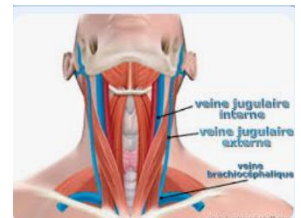
- Les veines jugulaires externes sont plus facilement examinables.
- On recherchera chez un patient installé en proclive dorsal à 45°.

1.1.une turgescence des veines jugulaires (TJ).

Le trajet des veines jugulaires externes passe en dehors du bord postéro-externe du muscle sternocléido-mastoïdien. Son aspect reflète les variations de pression de l'OD.

- Conditions d'examen :

Patient en décubitus dorsal en respiration normale, tête légèrement soulevée,



À l'état normal : pouls veineux plus visible que le pouls artériel mais non palpable

À l'état pathologique :

La distension permanente des jugulaires: (turgescence spontanée des jugulaires)
Il s'agit d'un signe d'insuffisance cardiaque droite :

- Insuffisance ventriculaire droite.
- Épanchement péricardique abondant.
- Péricardite constrictive.



1.2.Le reflux hépato-jugulaire (RHJ):

Technique :

Le patient est installé dans les mêmes conditions que pour la recherche d'une TJ. On se place à sa droite et on exerce avec le plat de la main droite une pression ferme sur le foie (dans l'hypochondre droit), tout en observant les veines jugulaires externes.



Résultat :

Le reflux hépato-jugulaire est positif s'il apparaît une turgescence jugulaire ou si une turgescence jugulaire préexistante se majore, ne disparaissant pas en inspiration profonde.

1.3.L'expansion systolique des jugulaires:

- Pouls systolique jugulaire de l'IT.
- Souvent associée à une expansion systolique du foie

1.4.La dissociation radio-Jugulaire :

Il s'agit d'un pouls jugulaire indépendant du pouls artériel :

- Le pouls veineux est soit plus rapide que le pouls artériel ; ce signe est retrouvé au cours de : bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré, du flutter auriculaire.
- Soit plus lent que le pouls artériel au cours de : la tachycardie ventriculaire.

2. L'examen des veines des membres inférieurs :**À l'état normal :**

Les veines des membres inférieurs ne sont pas visibles sauf au niveau de la malléole interne et du dos du pied.

À l'état pathologique : on recherche :

- Les varices des membres inférieurs
- la thrombose veineuse superficielle (TVS)
- La thrombose veineuse profonde (TVP)

a.Les varices des membres inférieurs :

Les varices correspondent à des dilatations tortueuses des veines du réseau de drainage superficiel des membres inférieurs.

- Position debout+++
- Disparaissent quand le membre est surélevé
- Peuvent se thromboser et entraîner ainsi une thrombose veineuse superficielle



b. La thrombose veineuse superficielle : TVS

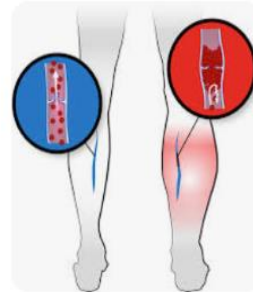
La TVS est une obstruction d'une veine superficielle par un thrombus, pouvant causer des complications si elle s'étend au système veineux profond.

- localisées aux membres inférieurs, aux membres supérieurs et au tronc.
- une douleur intense le long d'une veine, spontanée ou après un léger traumatisme, parfois aggravée par la marche
- Un placard inflammatoire très douloureux de forme oblongue. Il peut être circonscrit ou se poursuivre par un cordon veineux induré (1 à plusieurs dizaines de cm), sensible et violacé. Il n'y a pas d'adénopathie satellite associée. La limite supérieure du placard inflammatoire ou du cordon ne définit pas la limite supérieure du thrombus qui peut se situer beaucoup plus



c. La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs :

- Oblitération d'une veine profonde par un caillot sanguin.
- Sémiologie : Membre inférieur gonflé, rouge, chaud
- Douleur du mollet
- augmentation du volume : œdème
- augmentation de chaleur locale



- **Signe de Homans positif** : douleur provoquée du mollet à la dorsiflexion du pied.
- +/- signes de Pancarte (T°-FC)
- Complications :
 - Embolie pulmonaire.
 - Maladie post-phlébitique

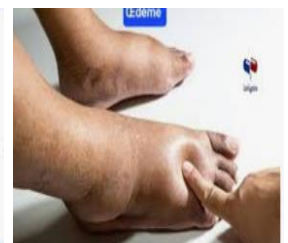


d. syndrome cave inférieure :

Le syndrome de la veine cave inférieure (SCVI) est causé par une invasion ou une compression physique par un processus pathologique ou par une thrombose dans la veine elle-même.

Il se manifeste par :

- Circulation veineuse collatérale abdominale
- Hépatomégalie, douleurs abdominales
- Ascite
- Œdème des membres inférieurs



e. syndrome cave supérieure :

Obstruction de la veine cave supérieure

- Œdème en pèlerine
- Cyanose
- Circulation collatérale thoracique
- Turgescence jugulaire
- Autres: myosis, hypotrophie de l'éminence hypothenar
- Congestion
- Gêne respiratoire: toux, dyspnée, oppression thoracique
- Signes neurologiques
- Céphalées
- Vertiges.



IV. Exploration de système vasculaire :

Système artériel :

Echographie-Doppler artérielle

- Artériographie
- Angioscanner
- Angio-IRM

Système veineux :

- Echographie-Doppler veineux
- Phlébographie

Dr Zineb Bouachiba
Maitre assistante EHDM
dr.bouachiba@gmail.com

